

Drº Mário Silveira

INDICADO POR: Drº Felipe

() ACOMPANHAMENTO ☒ CONSULTA

NS

VANIA CRISTINA DOS SANTOS

IMC 28.67

IDADE: 62 | PESO: 73.4 | ALTURA: 1.60 | PROFISSÃO: Professora - Apos.

SINTOMAS: Sono leve / adormecer durante / ganhou peso (30)

Dor no corpo

QUEIXAS: ardência da boca / ansiedade.

MEDICAMENTOS: esitalopram / Pregabalina (100mg)

MÉDICO: Drº Felipe

MARCAPASSO: () S ☒ N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S ☒ N

EXERCÍCIO FÍSICO: não faz

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: 5 | ALMOÇO: 5 | LANCHE: 5 | JANTAR: 5 (20:30)

HORA QUE DORME: 23:30 | HORA QUE ACORDA: 5h

COCHILOS () S () N 1:30 | DORME ACOMPANHADO: () S ☒ N () EVENTUALMENTE

TEM FILHOS: () S ☒ N | DORMEM NO QUARTO: () S ☒ N | PET NO QUARTO: () S ☒ N

BEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA ☒ N só em festas

FUMO: () S () MAÇO/DIA ☒ NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal | BANHEIRO/NOITE: 0X

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: normal | CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não | MALLAMPATI: | IAH: 48.9 | SPO2: 82%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Rinite (no passado) / Dor no corpo
torçoes da

CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA | D. Wear Pillow

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: —

COMORBIDADE: (S) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (N) CARDÍACA

(S) ORTOPÉDICA | (S) NEUROLÓGICA | () OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S () N | SPO2 CI/CPAP: | PRESSÃO NO EXAME: 7

17/07/25 Avaliação - Rotação

Nome: VANIA CRISTINA DOS SANTOS

Data de Nascimento: 16-12-1962

IMC: 28,67

Sexo: Feminino

Data do exame: 16-05-2024

Peso: 73,4 kg

Altura: 1,60 m

Médico: DR. MARIO SERGIO LEONE

CARREGOSA

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia para titulação de CPAP

Exame realizado na noite de 16-05-2024, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 518,5 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 119,0 e 188,5 minutos. O tempo total de sono foi de 360,0 min, eficiência de 69,4% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,9%; estágio N2: 60,6%; estágio N3: 19,4%; sono REM: 17,1%. O índice de despertares foi de 2,3/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 2,3/hora, sendo 5 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 9 hipopnéias. A SpO2 média foi de 96% e a mínima de 90%, permanecendo 0,0% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 44 - 55 bpm e NREM de 43 - 60 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (16), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. latências para o sono prolongadas;
4. número de despertares breves normal;
5. presença de movimentos periódicos de membros inferiores (6,8/hora);
6. registro de ronco durante o sono.

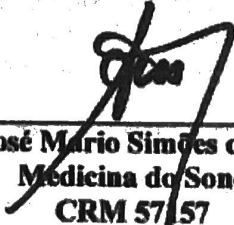
Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 7,0 cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

CA FORTES
advogados - advogados associados

Dr. A. Jerônimo Guimarães Fortes
CRM 24371

Dr. Felipe Sartor Guimarães Fortes
CRM 104318

Dr. Fernando Sartor Guimarães Fortes
CRM 120008

Prez. Claudio,

anexando a Sua Vossa Carta do Selo

que ataca a aceitação de CPAP

devido a SAOS grave.

(Potsomografia em a frente)

Dr. Felipe Sartor Guimarães Fortes
14/07/25